INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2)

1. Ficha de identificación

Evaluado	Ejemplo ficticio de contraste	**Documento de identidad**	DEMO-001
Fecha de nacimiento	15 de octubre de 1980	**Edad en la aplicación**	46
Sexo normativo	Mujer	**Fecha de aplicación**	3 de noviembre de 2026
Fecha del informe	11 de noviembre de 2026	**Modalidad de aplicación**	Excel
Contexto de evaluación	Clínico	**Evaluador**	Profesional ficticio

2. Motivo y objetivo de la evaluación

Solicitud sintética

3. Antecedentes e historia del caso

Antecedentes

Historia documental ficticia de seguimiento, con evolución de las dificultades y apoyos disponibles.

Historia del caso

Cronología ficticia detallada. La aplicación anterior se documenta en mayo de 2026 y la actual en noviembre de 2026.

4. Técnica, fuentes y control de calidad

Instrumento de autoinforme de 567 ítems. Referencia normativa seleccionada: Estados Unidos · Minnesota.

Las puntuaciones T se interpretan frente al grupo de referencia. T = 50 es el centro de la escala. En este informe, los rangos descriptivos son Bajo (<=39), Habitual (40–55), Promedio superior (56–59), Alto (60–69) y Muy alto (>=70). Los indicadores de validez conservan sus propios criterios.

5. Examen mental y observación conductual

No consta

6. Validez y estilo de respuesta

Tabla 1. Escalas de validez · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
VRIN	Inconsistencia de respuestas variables	7	—	46	Habitual	Respuestas coherentes entre afirmaciones de contenido similar u opuesto, sin inconsistencia relevante.
TRIN	Inconsistencia de respuestas verdadero	11	—	65V	Alto	Leve predominio de respuestas «Verdadero», sin alcanzar el umbral de inconsistencia relevante.
F	Infrecuencia	13	—	82	Muy alto	Reconocimiento muy elevado de experiencias poco frecuentes, compatible con malestar intenso o intensificación de síntomas.
Fb	Infrecuencia posterior	16	—	85	Muy alto	Respuestas poco frecuentes muy elevadas en la parte final del cuestionario, compatibles con malestar intenso o cambios en la forma de responder.
Fp	Infrecuencia psicopatológica	3	—	65	Alto	Sin elevación relevante de experiencias que son raras incluso en población clínica.
L	Mentira	5	—	57	Promedio superior	Reconocimiento de faltas o dificultades cotidianas sin una presentación favorable marcada.
K	Corrección	19	—	59	Promedio superior	Presentación de las dificultades dentro de límites habituales, sin elevación defensiva marcada.
S	Autopresentación superlativa	25	—	49	Habitual	Autodescripción positiva dentro de límites habituales, sin idealización marcada de la propia imagen.

> INTERPRETACIÓN. Inconsistencia de respuestas variables (VRIN, T = 46). Respuestas coherentes entre afirmaciones de contenido similar u opuesto, sin inconsistencia relevante. Inconsistencia de respuestas verdadero (TRIN, T = 65V). Leve predominio de respuestas «Verdadero», sin alcanzar el umbral de inconsistencia relevante. Infrecuencia (F, T = 82). Reconocimiento muy elevado de experiencias poco frecuentes, compatible con malestar intenso o intensificación de síntomas. Infrecuencia posterior (Fb, T = 85). Respuestas poco frecuentes muy elevadas en la parte final del cuestionario, compatibles con malestar intenso o cambios en la forma de responder. Infrecuencia psicopatológica (Fp, T = 65). Sin elevación relevante de experiencias que son raras incluso en población clínica. Mentira (L, T = 57). Reconocimiento de faltas o dificultades cotidianas sin una presentación favorable marcada. Corrección (K, T = 59). Presentación de las dificultades dentro de límites habituales, sin elevación defensiva marcada. Autopresentación superlativa (S, T = 49). Autodescripción positiva dentro de límites habituales, sin idealización marcada de la propia imagen.

Omisiones registradas: 0. Índice F - K (PD): -6.

Lectura del protocolo: interpretable con cautela.

- La infrecuencia elevada puede reflejar malestar intenso o intensificación de síntomas; por sí sola no establece simulación.

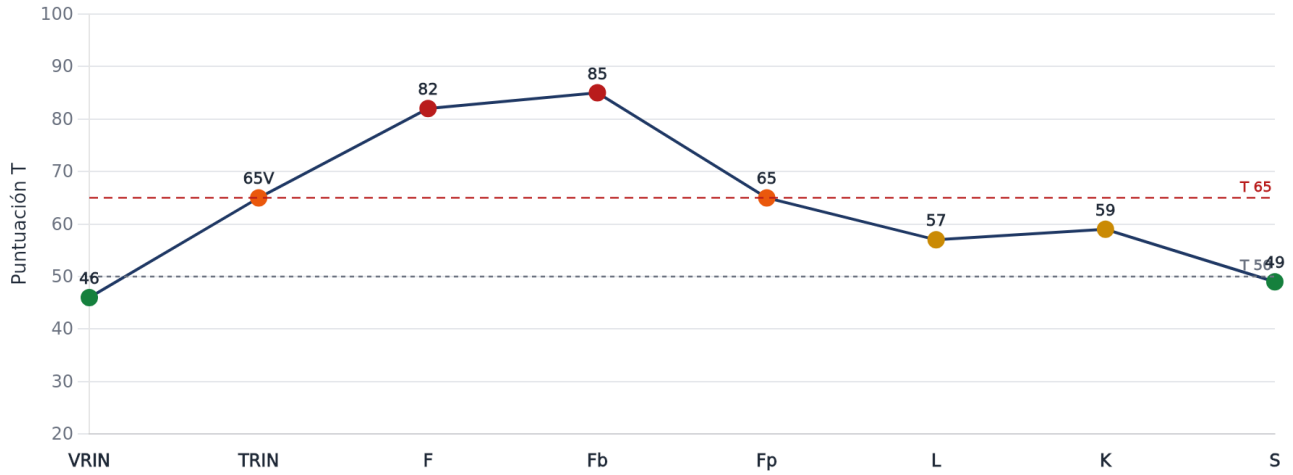


Figura 1. Perfil de escalas de validez.

Hay contenidos que requieren indagación clínica directa de seguridad. Documente vigencia, intención, medios y apoyos.

7. Escalas clínicas básicas

Tabla 2. Escalas clínicas básicas · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
Hs	Hipocondría	17	27	80	Muy alto	preocupación por la salud y quejas somáticas
D	Depresión	27	—	64	Alto	ánimo bajo, desánimo y pesimismo
Hy	Histeria de conversión	37	—	84	Muy alto	reacción somática al estrés y necesidad de aprobación
Pd	Desviación psicopática	20	28	63	Alto	insatisfacción, conflicto con normas y alienación
Mf	Masculinidad–feminidad	29	—	67	Alto	patrón de intereses y roles
Pa	Paranoia	15	—	67	Alto	suspicacia e hipersensibilidad interpersonal
Pt	Psicastenia	20	39	72	Muy alto	ansiedad, tensión y rumiación
Sc	Esquizofrenia	29	48	84	Muy alto	alienación, confusión y extrañeza
Ma	Hipomanía	25	29	76	Muy alto	energía elevada e impulsividad
Si	Introversión social	27	—	50	Habitual	Sin elevación

INTERPRETACIÓN. En las escalas clínicas básicas, 6 escalas de contenido clínico presentan T >=65. Mf se interpreta por separado en intereses y roles, sin clasificarla como elevación psicopatológica. La elevación marcada de Histeria de conversión (Hy, T = 84) describe una tendencia a reaccionar al estrés con síntomas físicos, uso de la negación como defensa, necesidad marcada de aprobación y afecto, y escasa conciencia de los propios conflictos emocionales. Esquizofrenia (Sc, T = 84) sugiere sentimientos de alienación y de ser diferente, aislamiento, dificultades de concentración y memoria, confusión y, en elevaciones altas, experiencias inusuales de pensamiento o percepción; en situaciones de estrés intenso puede reflejar desorganización emocional más que un proceso psicótico. Hipocondría (Hs, T = 80) señala preocupación excesiva por el funcionamiento corporal, quejas físicas múltiples y poco específicas, y tendencia a expresar el malestar psicológico a través de síntomas somáticos. Hipomanía (Ma, T = 76) apunta a un nivel elevado de energía y actividad, aceleración, irritabilidad, impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Psicastenia (Pt, T = 72) refleja ansiedad, tensión, preocupación constante, rumiación, inseguridad, autoexigencia elevada y sentimientos de culpa, con dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Masculinidad–feminidad (Mf, T = 67) describe un patrón de intereses que se aparta de los roles tradicionalmente atribuidos a lo femenino, con un estilo directo, práctico y orientado a la acción; esta escala no mide psicopatología. Paranoia (Pa, T = 67) sugiere suspicacia, hipersensibilidad a la crítica, sensación de ser tratada injustamente y tendencia a atribuir intenciones hostiles a los demás; en elevaciones marcadas conviene explorar ideación de referencia o persecutoria. En rango moderado (T 60–64) se ubican Depresión (D, T = 64; ánimo bajo, desánimo y pesimismo) y Desviación psicopática (Pd, T = 63; insatisfacción, conflicto con normas y alienación), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. La escala restante se mantiene dentro del rango esperado (T 40–59). Excluidas Mf y Si, que no se consideran en la codificación, el código de dos puntos es 3-8 (Hy-Sc), asociado en la literatura a malestar psicológico con quejas somáticas, confusión y dificultades de concentración. El código no está bien definido, porque la tercera escala (Hs, T = 80) dista menos de cinco puntos de la segunda; por ello, las descripciones del código deben leerse junto con las de esa escala.

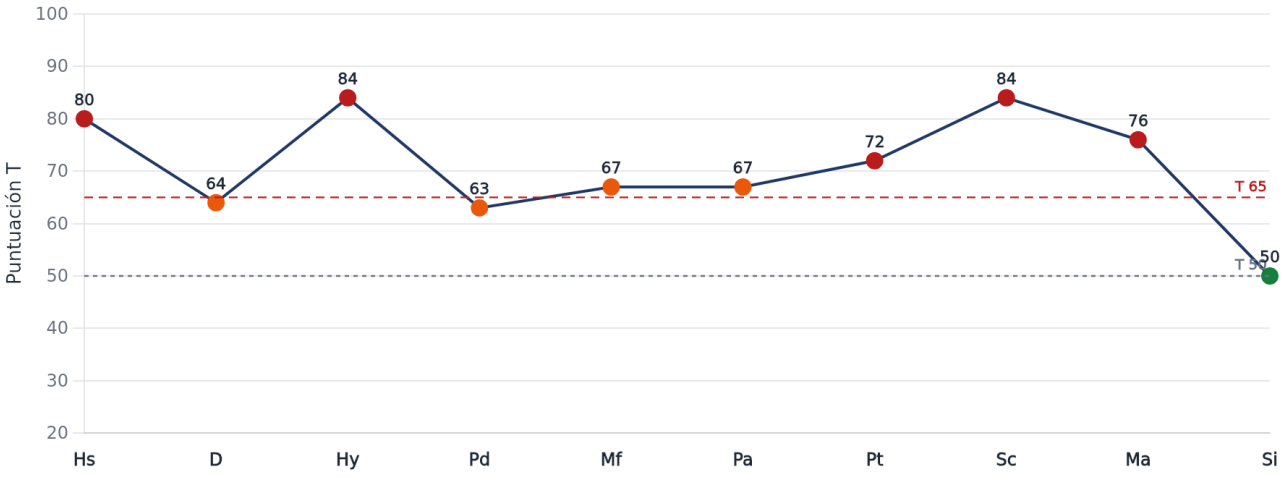


Figura 2. Perfil de escalas clínicas básicas.

8. Escalas de contenido

Tabla 3. Escalas de contenido · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
ANX	Ansiedad	7	—	51	Habitual	Sin elevación
FRS	Miedos	8	—	53	Habitual	Sin elevación
OBS	Obsesividad	10	—	**63**	**Alto**	rumiación e indecisión
DEP	Depresión (contenido)	10	—	58	Promedio superior	Sin elevación
HEA	Preocupaciones por la salud	20	—	**77**	**Muy alto**	preocupación por síntomas físicos
BIZ	Pensamiento extravagante	7	—	**67**	**Alto**	experiencias de pensamiento inusuales
ANG	Enojo	10	—	**64**	**Alto**	dificultad para controlar la ira
CYN	Cinismo	11	—	53	Habitual	Sin elevación
ASP	Prácticas antisociales	9	—	56	Promedio superior	Sin elevación
TPA	Comportamiento tipo A	9	—	53	Habitual	Sin elevación
LSE	Baja autoestima	13	—	**68**	**Alto**	autoconcepto negativo
SOD	Malestar social	9	—	52	Habitual	Sin elevación
FAM	Problemas familiares	9	—	57	Promedio superior	Sin elevación
WRK	Interferencia laboral	15	—	**61**	**Alto**	dificultades que afectan el desempeño laboral
TRT	Indicadores negativos de tratamiento	9	—	59	Promedio superior	Sin elevación

INTERPRETACIÓN. En las escalas de contenido, 3 escalas alcanzan un nivel clínicamente significativo (T >= 65). La elevación marcada de Preocupaciones por la salud (HEA, T = 77) describe numerosas preocupaciones por la salud y síntomas físicos en distintos sistemas corporales. Baja autoestima (LSE, T = 68) sugiere baja autoestima, autoconcepto negativo e inseguridad respecto de las propias capacidades. Pensamiento extravagante (BIZ, T = 67) señala experiencias de pensamiento o percepción extrañas o inusuales que conviene explorar clínicamente. En rango moderado (T 60–64) se ubican Enojo (ANG, T = 64; dificultad para controlar la ira), Obsesividad (OBS, T = 63; rumiación e indecisión) e Interferencia laboral (WRK, T = 61; dificultades que afectan el desempeño laboral), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. Las 9 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).

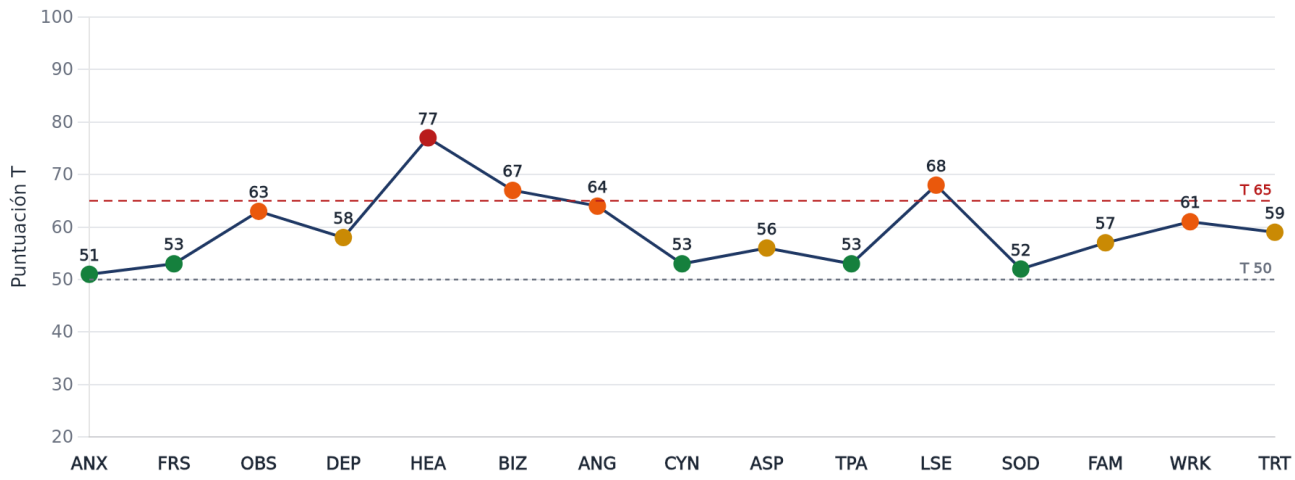


Figura 3. Perfil de escalas de contenido.

9. Escalas suplementarias y PSY-5

Tabla 4. Escalas suplementarias · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
A	Ansiedad (Welsh)	14	—	53	Habitual	Sin elevación
R	Represión	21	—	62	Alto	estilo inhibido y sobrecontrolado
Es	Fuerza del yo	22	—	<=30	Bajo	Recursos de afrontamiento percibidos reducidos y sensación de vulnerabilidad ante el estrés actual.
MAC-R	Alcoholismo de MacAndrew revisada	23	—	61	Alto	rasgos asociados al riesgo de consumo
AAS	Reconocimiento de adicción	5	—	67	Alto	reconocimiento de problemas de consumo
APS	Potencial de adicción	21	—	44	Habitual	Sin elevación
MDS	Malestar marital	5	—	59	Promedio superior	Sin elevación
Ho	Hostilidad	22	—	56	Promedio superior	Sin elevación
O-H	Hostilidad sobrecontrolada	13	—	48	Habitual	Sin elevación
Do	Dominancia	17	—	53	Habitual	Sin elevación
Re	Responsabilidad social	16	—	35	Bajo	menor compromiso con normas y responsabilidades sociales
Mt	Desajuste profesional	19	—	60	Alto	ineficacia y malestar ante las demandas
GM	Rol de género masculino	25	—	44	Habitual	Sin elevación
GF	Rol de género femenino	23	—	40	Habitual	Sin elevación
PK	Estrés postraumático (Keane)	17	—	63	Alto	malestar asociado a vivencias estresantes

Es: <=30 corresponde al límite inferior de reporte de la referencia estadounidense. La figura sitúa el resultado en T 30 y conserva el signo

<=. La puntuación se clasifica en rango Bajo.

INTERPRETACIÓN. En las escalas suplementarias, una escala alcanza un nivel clínicamente significativo (T >= 65). La elevación de Reconocimiento de adicción (AAS, T = 67) describe reconocimiento abierto de problemas relacionados con el consumo de alcohol u otras sustancias. En rango moderado (T 60–64) se ubican Estrés postraumático (Keane) (PK, T = 63; malestar asociado a vivencias estresantes), Represión (R, T = 62; estilo inhibido y sobrecontrolado), Alcoholismo de MacAndrew revisada (MAC-R, T = 61; rasgos asociados al riesgo de consumo) y Desajuste profesional (Mt, T = 60; ineficacia y malestar ante las demandas), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. La puntuación baja en Fuerza del yo (Es, T = <=30) indica recursos de afrontamiento percibidos reducidos y sensación de vulnerabilidad ante el estrés actual. La puntuación baja en Responsabilidad social (Re, T = 35) indica menor compromiso con normas y responsabilidades sociales. Las 8 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).

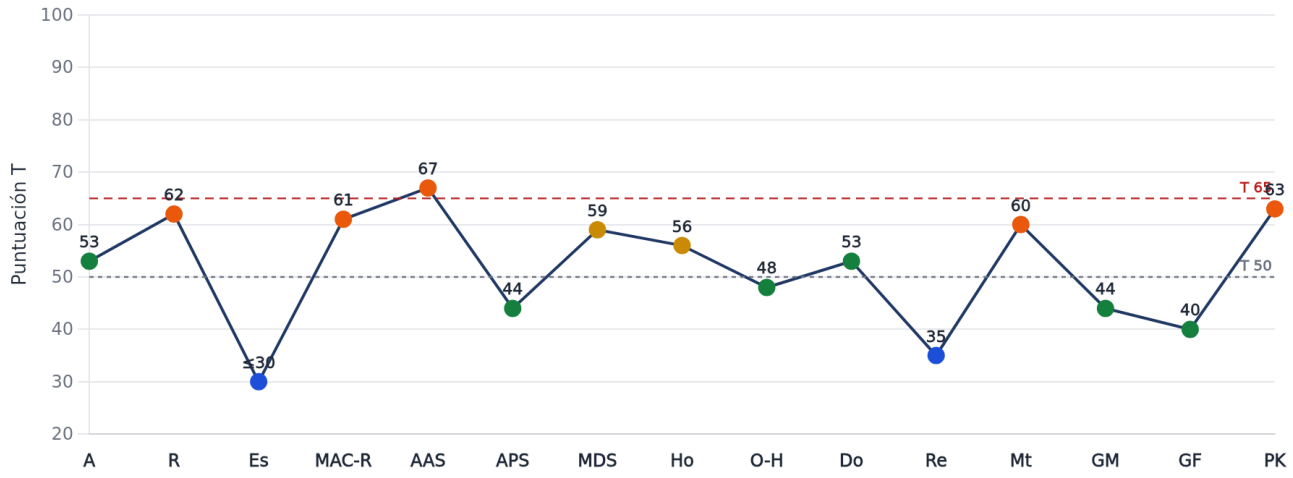


Figura 4. Perfil de escalas suplementarias. Es: <=30.

Personalidad PSY-5

Tabla 5. Dimensiones PSY-5 · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
AGGR	Agresividad	9	—	57	Promedio superior	Sin elevación
PSYC	Psicoticismo	2	—	46	Habitual	Sin elevación
DISC	Falta de control	15	—	**63**	**Alto**	desinhibición e impulsividad
NEGE	Emocionalidad negativa	11	—	49	Habitual	Sin elevación
INTR	Introversión/Baja emocionalidad positiva	12	—	53	Habitual	Sin elevación

INTERPRETACIÓN. Ninguna de las escalas de personalidad psicopatológica (PSY-5) alcanza un nivel clínicamente significativo (T >= 65). En rango moderado (T 60–64) se ubica Falta de control (DISC, T = 63; desinhibición e impulsividad), lo que indica una tendencia que conviene contrastar en la entrevista. Las 4 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).

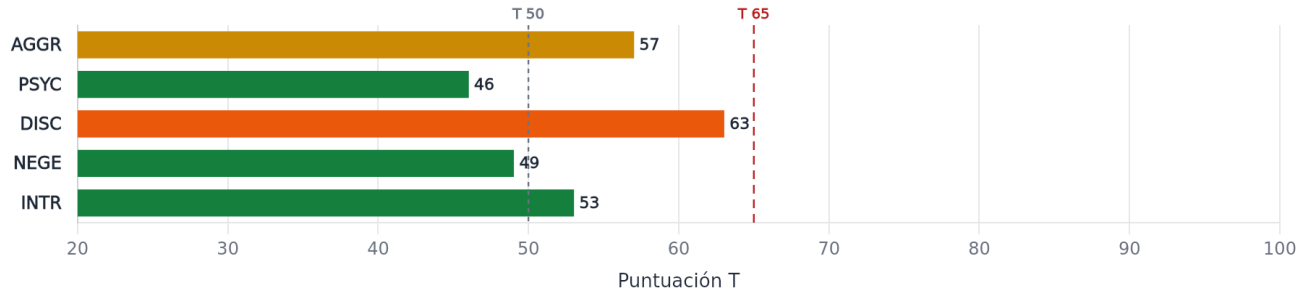


Figura 5. Perfil de dimensiones psy-5.

Correspondencia con clústeres DSM-5

Tabla 6. Correspondencia dimensional orientativa

Clúster	Dimensiones de referencia	T máxima	Rango de T	Rasgos del área
A	PSYC	46	Habitual	Raro o excéntrico: desconfianza, distancia emocional, pensamiento o percepciones inusuales (paranoide, esquizoide, esquizotípico)
B	AGGR, DISC	63	Alto	Dramático, emocional o errático: impulsividad, inestabilidad afectiva, dominancia o transgresión de normas (antisocial, límite, histriónico, narcisista)
C	NEGE, INTR	53	Habitual	Ansioso o temeroso: inseguridad, temor al rechazo o al error, necesidad de apoyo, inhibición (evitativo, dependiente, obsesivo-compulsivo)

Correspondencia conceptual para contrastar con entrevista y trayectoria clínica.

> INTERPRETACIÓN. Las escalas PSY-5 describen rasgos de personalidad relativamente estables y permiten una lectura dimensional que la literatura relaciona, de forma conceptual y no diagnóstica, con los grupos de trastornos de personalidad del DSM-5. En grado moderado aparece el área del clúster B (AGGR, T = 57; DISC, T = 63). No hay elevaciones en las dimensiones vinculadas a los clústeres A y C. Dado el estilo de respuesta observado, estas dimensiones deben leerse con la misma cautela que el resto del perfil. Un diagnóstico de trastorno de personalidad requiere establecer un patrón persistente desde la adolescencia o la adultez temprana, con entrevista específica (p. ej., SCID-5-PD) e información de terceros; el MMPI-2 por sí solo no lo establece.

10. Subescalas Harris-Lingoes

Tabla 7. Subescalas Harris-Lingoes y de Introversión social · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
D1	Depresión subjetiva	16	—	**70**	**Muy alto**	tristeza y falta de energía
D2	Retardo psicomotor	7	—	57	Promedio superior	Sin elevación
D3	Disfunción física	8	—	**85**	**Muy alto**	preocupación por el estado físico
D4	Torpeza mental	7	—	**70**	**Muy alto**	quejas cognitivas
D5	Rumiación	4	—	58	Promedio superior	Sin elevación
Hy1	Negación de ansiedad social	4	—	51	Habitual	Sin elevación
Hy2	Necesidad de afecto	10	—	**63**	**Alto**	necesidad de afecto

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T	Lectura breve
Hy3	Lasitud-malestar	11	—	83	Muy alto	cansancio y malestar físico
Hy4	Quejas somáticas	7	—	65	Alto	quejas somáticas múltiples
Hy5	Inhibición de la agresión	3	—	46	Habitual	Sin elevación
Pd1	Discordia familiar	6	—	74	Muy alto	conflicto familiar
Pd2	Problemas con la autoridad	2	—	46	Habitual	Sin elevación
Pd3	Imperturbabilidad social	5	—	58	Promedio superior	Sin elevación
Pd4	Alienación social	3	—	44	Habitual	Sin elevación
Pd5	Autoalienación	4	—	53	Habitual	Sin elevación
Pa1	Ideas persecutorias	3	—	57	Promedio superior	Sin elevación
Pa2	Hipersensibilidad	4	—	59	Promedio superior	Sin elevación
Pa3	Ingenuidad	5	—	50	Habitual	Sin elevación
Sc1	Alienación social	6	—	61	Alto	sentirse rechazada
Sc2	Alienación emocional	5	—	86	Muy alto	distanciamiento afectivo
Sc3	Falta de dominio cognitivo del yo	4	—	67	Alto	sensación de perder el control del pensamiento
Sc4	Falta de dominio conativo del yo	5	—	65	Alto	falta de motivación
Sc5	Falta de inhibición	2	—	53	Habitual	Sin elevación
Sc6	Experiencias sensoriales extrañas	10	—	86	Muy alto	experiencias perceptivas inusuales
Ma1	Amoralidad	4	—	70	Muy alto	actitud utilitaria
Ma2	Aceleración psicomotora	6	—	55	Habitual	Sin elevación
Ma3	Imperturbabilidad	5	—	62	Alto	despreocupación por la opinión ajena
Ma4	Autoenvanecimiento	5	—	62	Alto	autoimagen exagerada
Si1	Timidez	4	—	46	Habitual	Sin elevación
Si2	Evitación social	2	—	47	Habitual	Sin elevación
Si3	Alienación de sí y de otros	6	—	52	Habitual	Sin elevación

INTERPRETACIÓN. Las subescalas de Harris-Lingoes y de Introversión social precisan el contenido de las escalas clínicas y se interpretan sobre todo cuando su escala madre está elevada (T >= 60); en caso contrario, su lectura es orientativa. En las subescalas, 11 escalas alcanzan un nivel clínicamente significativo (T >= 65). La elevación marcada de Alienación emocional (Sc2, T = 86) describe distanciamiento afectivo, apatía o desesperanza, coherente con la elevación de su escala madre (Sc, T = 84). Experiencias sensoriales extrañas (Sc6, T = 86) sugiere experiencias corporales o perceptivas inusuales, coherente con la elevación de su escala madre (Sc, T = 84). Disfunción física (D3, T = 85) señala preocupación por el propio funcionamiento físico, coherente con la elevación de su escala madre (D, T = 64). Lasitud-malestar (Hy3, T = 83) apunta a cansancio, debilidad y sensación general de no estar bien, coherente con la elevación de su escala madre (Hy, T = 84). Discordia familiar (Pd1, T = 74) refleja percepción de la familia como poco afectuosa y conflictiva, coherente con la elevación de su escala madre (Pd, T = 63). Depresión subjetiva (D1, T = 70) describe tristeza, falta de energía e interés, y dificultad para afrontar los problemas, coherente con la elevación de su escala madre (D, T = 64). Torpeza mental (D4, T = 70) sugiere falta de energía mental, dificultades de concentración y de memoria, y desconfianza en el propio juicio, coherente con la elevación de su escala madre (D, T = 64). Amoralidad (Ma1, T = 70) señala una actitud utilitaria y cierta justificación del engaño, coherente con la elevación de su escala madre (Ma, T = 76). Falta de dominio cognitivo del yo (Sc3, T = 67) apunta a sensación de pérdida de control sobre el propio pensamiento, dificultades de concentración y de memoria, y vivencias de extrañeza, coherente con la elevación de su escala madre (Sc, T = 84). Quejas somáticas (Hy4, T = 65) refleja quejas somáticas múltiples, como dolores de cabeza o molestias cardiorrespiratorias y digestivas, coherente con la elevación de su escala madre (Hy, T = 84). Falta de dominio conativo del yo (Sc4, T = 65) describe falta de energía y de motivación, y sensación de que la vida es una carga, coherente con la elevación de su escala madre (Sc, T = 84). En rango moderado (T 60–64) se ubican Necesidad de afecto (Hy2, T = 63; necesidad de afecto), Imperturbabilidad (Ma3, T = 62; despreocupación por la opinión ajena), Autoenvanecimiento (Ma4, T = 62; autoimagen exagerada) y Alienación social (Sc1, T = 61; sentirse rechazada), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. Las 16 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).

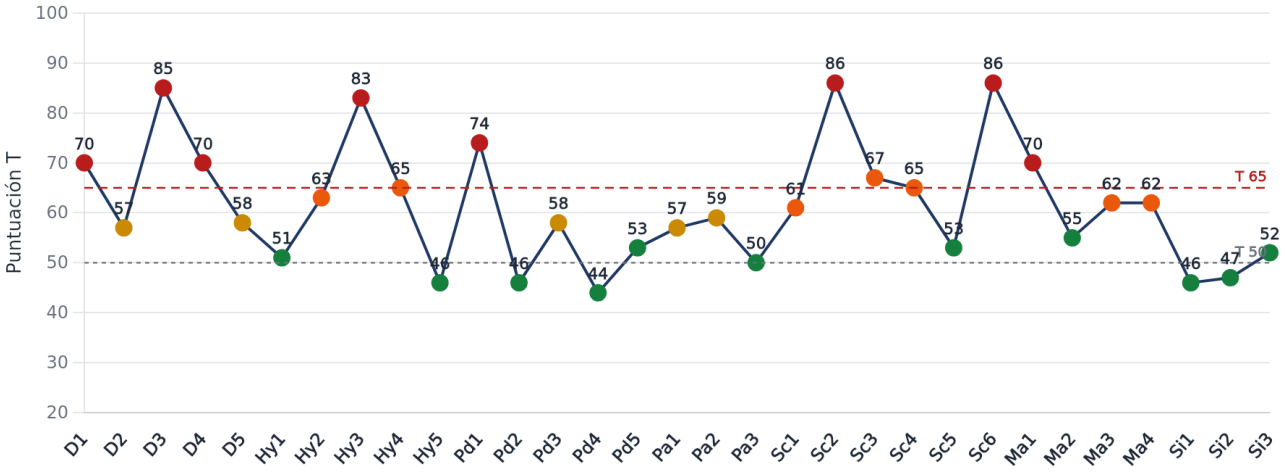


Figura 6. Perfil de subescalas harris-lingoes y de introversión social.

11. Ítems críticos

Tabla 8. Contenidos críticos agrupados por tema

Ítem	Respuesta	Paráfrasis temática
2	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa. Malestar afectivo y preocupaciones.
10	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa. Malestar afectivo y preocupaciones.
28	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa. Molestias corporales o preocupación por la salud.
59	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa. Molestias corporales o preocupación por la salud.
172	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
223	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
463	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
60	V	Atención y experiencias inusuales · Experiencias o pensamientos inusuales.
96	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión. Experiencias o pensamientos inusuales.
106	F	Atención y experiencias inusuales · Creencias que requieren contexto.
122	V	Atención y experiencias inusuales · Experiencias o pensamientos inusuales.
124	V	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza.
298	V	Atención y experiencias inusuales · Experiencias o pensamientos inusuales.
299	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión. Tensión o activación ansiosa.
307	V	Atención y experiencias inusuales · Experiencias o pensamientos inusuales.
311	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión.
314	F	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza. Creencias que requieren contexto.
333	V	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza. Creencias que requieren contexto.
33	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
47	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
57	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
101	V	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
142	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
159	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
175	V	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
247	V	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
255	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
295	F	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
464	V	Bienestar físico · Molestias corporales o preocupación por la salud.
125	F	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol. Tensiones o experiencias en el contexto familiar.
429	F	Consumo de sustancias · Experiencias relacionadas con consumo.
487	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.

Ítem	Respuesta	Paráfrasis temática
489	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
502	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
9	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
65	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia. Malestar afectivo y preocupaciones.
71	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
73	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar afectivo y preocupaciones.
75	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia. Malestar afectivo y preocupaciones.
95	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
146	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
339	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar afectivo y preocupaciones.
388	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
411	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia. Malestar afectivo y preocupaciones.
485	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
506	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
62	F	Experiencias e inquietudes sobre sexualidad · Experiencias o preocupaciones relacionadas con la sexualidad.
121	F	Experiencias e inquietudes sobre sexualidad · Experiencias o preocupaciones relacionadas con la sexualidad.
27	V	Ira y convivencia · Actitudes frente a normas y convivencia.
85	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal. Expresión o regulación del enojo.
134	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal. Expresión o regulación del enojo.
389	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal. Expresión o regulación del enojo.
83	F	Relaciones familiares · Tensiones o experiencias en el contexto familiar.
288	V	Relaciones familiares · Tensiones o experiencias en el contexto familiar.
30	V	Sueño · Dificultades relacionadas con el sueño.
328	V	Sueño · Dificultades relacionadas con el sueño.
471	V	Sueño · Dificultades relacionadas con el sueño.

Los contenidos críticos orientan preguntas de entrevista. La valoración actual del riesgo requiere evaluación directa.

12. Integración clínica

Distribución e intensidad de las elevaciones

> INTERPRETACIÓN. De las 71 escalas sustantivas con puntuación T (clínicas, de contenido, suplementarias y subescalas), 14 se sitúan en rango muy alto (T >= 70), 21 en rango alto (T 60–69) y 2 en rango bajo (T <= 39); el resto se mantiene en rangos medios. La mayor proporción de elevaciones se concentra en las escalas clínicas básicas (9 de 10), lo que indica dónde se localiza con más claridad el malestar autoinformado.

> INTERPRETACIÓN. Las 21 escalas con elevación clínicamente significativa se agrupan en 6 áreas de funcionamiento. La de mayor intensidad corresponde al área emocional (Sc2, T = 86; Pt, T = 72; D1, T = 70; LSE, T = 68; Sc4, T = 65). Le siguen, por orden de intensidad, el funcionamiento cognitivo y perceptivo (Sc6, T = 86; Sc, T = 84; D4, T = 70; BIZ, T = 67; Sc3, T = 67), el área somática (D3, T = 85; Hy, T = 84; Hy3, T = 83; Hs, T = 80; HEA, T = 77; Hy4, T = 65), la regulación de la conducta y los impulsos (Ma, T = 76; Ma1, T = 70; AAS, T = 67), la vida familiar y de pareja (Pd1, T = 74) y las relaciones interpersonales (Pa, T = 67). La convergencia de varias escalas en una misma área aumenta la solidez de la hipótesis; las elevaciones aisladas requieren mayor contraste con la entrevista y otras fuentes.

Configuración del perfil clínico

Excluidas Mf y Si, que no se consideran en la codificación, el código de dos puntos es 3-8 (Hy-Sc), asociado en la literatura a malestar psicológico con quejas somáticas, confusión y dificultades de concentración. El código no está bien definido, porque la tercera escala (Hs, T = 80) dista menos de cinco puntos de la segunda; por ello, las descripciones del código deben leerse junto con las de esa escala.

V de conversión: Hipocondría e Histeria elevadas por encima de Depresión: tendencia a expresar el malestar en síntomas físicos con menor reconocimiento del componente emocional.

Elevación conjunta de Paranoia y Esquizofrenia: Suspicacia y posible alteración del pensamiento: valorar ideación paranoide.

Elevación conjunta de Psicastenia y Esquizofrenia: Malestar intenso, rumiación, inseguridad y dificultades de concentración; con Pt próxima o superior a Sc predomina el componente ansioso.

13. Recursos y fortalezas

No constan fortalezas documentadas en entrevista ni elevaciones en las escalas de recursos seleccionadas.

14. Contraste longitudinal

Aplicación anterior del 27 de mayo de 2026.

Fuente anterior: Profesional de prueba.

Tabla 9. Puntuaciones anteriores y actuales documentadas

Escala	Puntuación anterior	T actual	Diferencia T	Lectura
VRIN	76	46	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
TRIN	50	65V	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
Fb	96	85	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
Mf	56	67	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar

Se conservan las puntuaciones previas tal como se documentaron. La diferencia T requiere el mismo baremo, sexo normativo, clave y fuente de corrección.

Las diferencias son descriptivas. Los valores aproximados, pendientes o con límites no se restan.

Se contrastan 4 escalas documentadas del registro anterior con el actual. La comparación disponible es documental: se conservan los valores publicados y la interpretación de cambio clínico permanece pendiente.

Validez y estilo de respuesta. VRIN: T anterior 76 y T actual 46; TRIN: T anterior 50 y T actual 65V; Fb: T anterior 96 y T actual 85.

Escalas clínicas. Mf: T anterior 56 y T actual 67.

La consistencia actual se describe mediante VRIN: el registro actual presenta respuestas coherentes entre afirmaciones de contenido similar u opuesto. La diferencia entre los valores publicados de ambas fechas requiere confirmar las condiciones y referencias antes de interpretarse como cambio.

Aspectos pendientes de comparabilidad: sexo normativo anterior sin confirmar; versión, clave y fuente de corrección sin confirmar; dirección de trin no coincidente o no documentada. La gráfica muestra las puntuaciones T publicadas en su escala original. Sus diferencias visuales no establecen mejoría, deterioro ni equivalencia normativa.

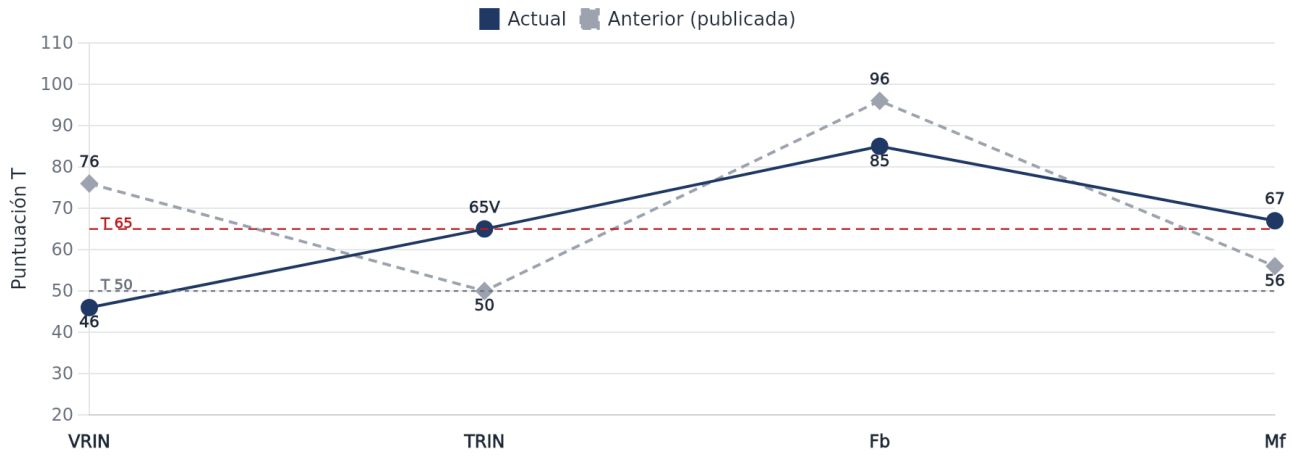


Figura 7. Contraste documental de T publicadas · comparabilidad pendiente.

15. Impresión diagnóstica (tentativa)

No consta entrevista clínica suficiente para formular una impresión diagnóstica tentativa.

16. Limitaciones de la evaluación

La aplicabilidad de la referencia normativa seleccionada depende de la población y de las condiciones de aplicación.

Entrevista clínica suficiente pendiente de documentar.

17. Conclusiones

En la presente evaluación en contexto clínico, la evaluada respondió el inventario de forma coherente y atenta al contenido de las preguntas, con apertura para reconocer malestar y una tendencia a acentuar su intensidad que puede expresar sufrimiento elevado o una necesidad de ser escuchada, motivo por el cual la magnitud de algunos hallazgos debe ponderarse con prudencia. El hallazgo más prominente se sitúa en el funcionamiento cognitivo y perceptivo, donde el perfil describe, con una intensidad marcada, experiencias de pensamiento o percepción inusuales, sensación de confusión y dificultad para organizar el pensamiento, quejas de concentración, memoria y energía mental y una tendencia a interpretar la conducta ajena como hostil.

En el área emocional se aprecia, de forma igualmente acusada, distanciamiento afectivo y apatía, ansiedad, tensión y preocupación persistente, rumiación, autoexigencia y sentimientos de culpa y tristeza y desgaste para afrontar los problemas. Respecto del área somática, las respuestas reflejan, con nitidez, preocupación por el estado físico, síntomas físicos que se intensifican en momentos de tensión, cansancio y sensación general de no estar bien y una preocupación persistente por la salud física.

En cuanto a las relaciones interpersonales, destaca, con claridad, una necesidad intensa de aprobación y afecto, sentimientos de alienación y distancia respecto de los demás, desconfianza e hipersensibilidad a la crítica e insatisfacción y resentimiento en sus vínculos cercanos. A ello se suma, en la regulación de la conducta y los impulsos, aceleración, irritabilidad e impulsividad, actitudes de transgresión de normas, reconocimiento de problemas relacionados con el consumo e irritabilidad y dificultad para modular el enojo. A ello se suma, en la vida familiar y de pareja, percepción de conflicto y de escaso apoyo familiar. La coexistencia de quejas corporales y malestar emocional sugiere que la tensión psicológica se vive en buena medida a través del cuerpo, de forma que ambos planos tienden a reforzarse.

Las vivencias de confusión o extrañeza pueden corresponder al desbordamiento emocional que acompaña al malestar; su naturaleza y alcance deben precisarse en la entrevista clínica. En menor grado, aparecen malestar compatible con vivencias estresantes o traumáticas y dificultades que interfieren con el desempeño laboral. En su estilo de personalidad se reconoce poca conciencia de los propios conflictos emocionales, un estilo directo y práctico, poco ajustado a los roles de género tradicionales y un estilo inhibido, convencional y sobrecontrolado.

De cara a la intervención, conviene considerar la presencia de recursos de afrontamiento debilitados frente al estrés, lo que hace aconsejable cuidar especialmente la alianza de trabajo y el encuadre de objetivos alcanzables. Estos resultados describen cómo la persona se percibe y se presenta en el momento de la evaluación; su alcance diagnóstico depende de su integración con la entrevista clínica, la historia personal y la información de otras fuentes. Pese a que las medidas de ánimo no muestran elevación, reconoció pensamientos de contenido suicida que, por su gravedad potencial, requieren una valoración directa del riesgo; esa discrepancia no reduce su relevancia y debe esclarecerse en entrevista.

Entre las afirmaciones de mayor relevancia clínica que reconoció destacan las relativas a estado de ansiedad aguda, ideación suicida depresiva, amenaza de ataque, estrés ocasionado por el alcoholismo y confusión mental, que conviene explorar en entrevista.

18. Recomendaciones

- Realizar una valoración directa y estructurada del riesgo suicida (ideación, plan, intentos previos, acceso a medios y factores protectores), dado el reconocimiento de ítems críticos de contenido suicida, y documentar sus resultados.
- Explorar antecedentes de conducta agresiva y control de impulsos, contrastando con fuentes colaterales, a partir de los ítems críticos de amenaza de ataque reconocidos.
- Contrastar las elevaciones con la entrevista clínica, la historia documentada y otras fuentes, dado el estilo de respuesta observado.
- Coordinar con medicina para descartar o precisar la base orgánica de las quejas físicas y evitar exploraciones redundantes; considerar intervenciones dirigidas a la relación entre estrés y síntomas

corporales.

- Valorar la ansiedad y la rumiación con medidas específicas; las intervenciones cognitivo-conductuales y de regulación emocional suelen ser pertinentes.
- Explorar en entrevista la calidad del pensamiento, la concentración y las experiencias perceptivas, para diferenciar desorganización por estrés intenso de alteraciones de otra naturaleza.
- Valorar el manejo de la ira y de los impulsos y, si procede, el riesgo para sí o para terceros.
- Explorar el patrón de consumo de alcohol y otras sustancias con instrumentos de cribado.
- Fortalecer la alianza terapéutica y trabajar las expectativas sobre el tratamiento desde el inicio, dado el pesimismo o la fragilidad de los recursos de afrontamiento.
- Integrar estos resultados con la entrevista clínica, la historia y la información de otras fuentes; el inventario describe el funcionamiento autoinformado y no establece por sí solo diagnósticos ni relaciones causales.

Referencias técnicas

- Butcher, J. N. et al. (2001). MMPI-2: Manual for administration, scoring, and interpretation. University of Minnesota Press.

Evaluador y firma

Ciudad de prueba · 11 de noviembre de 2026

Profesional ficticio